

TEPT — Trastorno de Estrés Postraumático

TCC — Ficha clínica

DESCRIPCIÓN DEL TRASTORNO

El TEPT se desarrolla tras la exposición a un evento traumático e incluye síntomas de reexperimentación (flashbacks, pesadillas), evitación, alteraciones cognitivas y emocionales negativas persistentes e hiperactivación. Los tratamientos con mayor evidencia son la **Terapia de Procesamiento Cognitivo (CPT)** y la **Terapia de Exposición Prolongada (PE)**.

TÉCNICAS E INTERVENCIONES TCC — PASO A PASO

1	Psicoeducación del TEPT Explicar la respuesta al trauma como reacción normal a un evento anormal. Presentar el modelo de procesamiento incompleto del trauma: los recuerdos no fueron 'archivados' porque el sistema de amenaza permaneció activo.
2	Estabilización y recursos antes de procesar Evaluar seguridad actual. Enseñar regulación del sistema nervioso (anclaje al presente, respiración). No iniciar exposición sin estabilidad mínima. En trauma complejo, esta fase puede tomar meses.
3	Exposición prolongada (PE) — Exposición imaginaria El paciente narra el trauma en presente, con detalle sensorial, durante 45-60 min. El terapeuta acompaña sin redirigir.
4	Exposición en vivo a estímulos evitados Jerarquía de situaciones/objetos/personas evitados por asociación con el trauma. Exposición graduada. Distinguir peligro real de asociación condicionada.
5	CPT — Reestructuración de puntos de inflexión Identificar los 'puntos de inflexión cognitivos': afirmaciones sobre el trauma, uno mismo y el mundo. Ej: 'debí haberlo impedido', 'el mundo es completamente inseguro'. Trabajar con hojas de análisis específicas.
6	Procesamiento del significado del trauma Explorar cómo el trauma afectó las creencias sobre seguridad, confianza, poder/control, estima y relaciones. Construir narrativa integrada que incluya el trauma sin ser definida por él.

ADAPTACIONES POR POBLACIÓN

Población	Adaptaciones y consideraciones
Adultos	Evaluar trauma complejo vs. TEPT simple. En trauma complejo (múltiple, crónico, interpersonal), priorizar estabilización y regulación. La PE estándar puede no ser suficiente.
Adolescentes	Evaluar contexto: abuso intrafamiliar, violencia, accidentes. TF-CBT (Trauma-Focused CBT) tiene fuerte evidencia. Siempre trabajar con sistema familiar cuando es seguro.

TEPT — Trastorno de Estrés Postraumático

TCC — Ficha clínica

Población	Adaptaciones y consideraciones
Niños	TF-CBT es el tratamiento de elección. Incluye narrativa del trauma adaptada. Involucrar al cuidador no-ofensor en cada sesión. Evaluar impacto en desarrollo y apego.

Clave clínica: Nunca iniciar exposición sin evaluar ventana de tolerancia y estabilidad.